

Die Kostenfrage in der Praxis

Was Sie sagen dürfen, ohne zu beraten, und wo Ihre Rolle endet

Ein Leitfaden für Praxen in Heilberufen: Heilpraktik, Osteopathie, Physiotherapie, Hebammenarbeit.

Stand 23.09.2026

Herausgeberin: Healio GmbH, Hamburg

Worum es hier geht

Der Termin wird verschoben. Beim zweiten Mal kommt gar keine neue Anfrage mehr. Offen sagt das am Empfang niemand. Da heißt es „ich melde mich wieder“, und gemeint ist oft „ich kann das gerade nicht mehr bezahlen“.

Der Abbruch kostet zweimal. Den Patienten die Behandlung, die gerade anfang zu wirken, und Sie die Stunde im Kalender. Dabei hat kaum jemand aus Überzeugung abgelehnt. Die meisten wissen nur nicht, woher sie das Geld nehmen sollen, und fragen deshalb gar nicht erst nach.

Dieses Buch beantwortet eine einzige Frage: Was darf eine Praxis dazu sagen, ohne die eigene Rolle zu verlassen. Es macht Ihre Praxis nicht zur Beratungsstelle und gibt Ihnen keinen Verkaufsleitfaden an die Hand. Es zieht eine Linie, an der Sie sich im Alltag festhalten können, und liefert Sätze, die diesseits dieser Linie bleiben.

Eine Vorbemerkung zur Haltung, bevor es um Regeln geht. Ihre Patienten bringen Ihnen Vertrauen mit. Sie erzählen Ihnen Dinge, die sonst niemand von ihnen hört, und sie fragen links und rechts nach, wie das mit den Rechnungen eigentlich läuft. Wenn dann ein Termin verschoben wird, weil das Geld gerade nicht da ist, steht dieses Vertrauen mit im Raum.

Es ist eine Schande, dass Menschen ihre Behandlung abbrechen und ihre Rechnungen still selbst bezahlen, während im selben Jahr Beträge bei ihrer Kasse liegen bleiben. Niemand ruft sie ab, weil es ihnen niemand sagt. Sie sind für viele Patienten die erste vertraute Ansprechperson im Gesundheitswesen, oft die einzige. Dass es einen Weg gibt, dürfen Sie aussprechen, und Sie sollten es tun. Prüfen und entscheiden muss der Patient selbst. Ihn zu verschweigen, wäre ein Versäumnis, für das wir gemeinsam geradestehen.

Dafür muss sich niemand schämen. Viele Behandler wollen ihren Patienten ohnehin unter die Arme greifen, trauen sich aber nicht, weil sie fürchten, damit etwas zu verkaufen. Wer Ihnen Vertrauen und Geld in die Praxis bringt, darf etwas zurückbekommen, und sei es nur ein Satz: Es gibt eine Möglichkeit, wie Sie sich einen Teil davon zurückholen können. Prüfen müssen Sie sie selbst.

Kapitel 1. Woran Sie merken, dass es um Geld geht

Patienten sagen selten „zu teuer“. Sie sagen etwas anderes, und meistens klingt es nach Terminorganisation.

Achten Sie auf diese Muster. Der Abstand zwischen den Terminen wird größer, ohne dass sich fachlich etwas geändert hat. Ein Termin wird abgesagt und nicht neu vereinbart, sondern vertagt: „Ich melde mich, wenn es ruhiger ist.“ Die Serie wird von sich aus verkürzt, oft mit einer Begründung, die zu gut klingt: „Mir geht es schon viel besser.“ Beim Thema Umfang fällt der Blick kurz zur Seite. Eine empfohlene Zusatzleistung wird ohne Nachfrage abgelehnt, obwohl vorher Interesse da war.

Ein zweites Signal ist die Art der Frage. Wer an der Behandlung zweifelt, fragt nach dem Warum und nach Alternativen. Wer am Geld hängt, fragt nach Anzahl und Dauer: Wie viele Termine sind das noch, reichen nicht auch weniger, geht das auch in größeren Abständen. Das sind Kostenfragen in fachlicher Verkleidung.

Der Unterschied ist wichtig, weil er Ihre Reaktion bestimmt. Fachliche Zweifel gehören ins Gespräch über die Behandlung, das ist Ihr Kerngebiet. Eine Kostenfrage braucht eine eigene Antwort. Wer sie im Behandlungsgespräch mitverhandelt, landet beim Rabatt oder bei einer verkürzten Therapie, und damit ist weder dem Patienten noch Ihnen geholfen. Überhören sollten Sie die Frage deshalb trotzdem nicht. Sie verdient einen eigenen Satz, und den dürfen Sie sagen.

Ein dritter Hinweis kommt aus dem Umfeld. Wenn jemand fragt, ob die Behandlung auch von einer anderen Stelle bezahlt werden kann, ob eine Quittung für irgendeinen Nachweis taugt oder ob es die Serie auch im nächsten Kalenderjahr noch gibt, dann rechnet dieser Mensch bereits. Solche Fragen sind kein Misstrauen, sondern der Versuch, die Behandlung irgendwie weiterlaufen zu lassen.

Und noch etwas: Scham spielt mit. Kaum jemand sagt in einem Behandlungsraum gern, dass das Geld knapp ist. Deshalb löst Nachbohren nichts. Was hilft, ist ein Umfeld, in dem der Patient die Frage von sich aus stellen kann, ohne sich dabei klein zu machen. Und wenn er sie stellt, hilft eine Antwort, die ihn ernst nimmt, statt ihn höflich weiterzuschicken.

Kapitel 2. Die Rollentrennung

Hier liegt der Kern dieses Buches. Es gibt einen Bereich, in dem Sie sich frei bewegen können, und es gibt eine Grenze, hinter der Sie Versicherungsberatung leisten würden. Diese Grenze verläuft nicht dort, wo die meisten sie vermuten.

Allgemein über eine Möglichkeit zu informieren, ist Ihnen erlaubt. Dass gesetzliche Krankenkassen Bonusprogramme führen und dass es private Zusatzverträge gibt, dürfen Sie aussprechen. Auch der Verweis auf eine Quelle, in der jemand selbst nachsieht, ist gedeckt. All das ist allgemeine Information und keine Beratung. Es ist außerdem der Teil, auf den es ankommt, denn ohne diesen einen Satz erfährt der Patient von der ganzen Sache nie etwas.

Beratung beginnt, sobald es um den konkreten Fall geht. Welcher Vertrag zu diesem Patienten passt, ob eine bestimmte Behandlung erstattet wird, ob der Zeitpunkt gerade günstig ist, wie eine Bedingung im Kleingedruckten zu verstehen ist: Das sind Fragen, die ein Praxisteam nicht beantworten kann und nicht beantworten soll. Nicht aus Vorsicht, sondern weil eine falsche Auskunft an dieser Stelle teuer wird, und zwar für den Patienten.

Die fünf Grenzen

1. Die Praxis informiert allgemein über eine Möglichkeit, nicht über einen Einzelfall.
2. Die Praxis empfiehlt keinen Versicherer und keinen Tarif.
3. Die Praxis berät nicht zu Bedingungen, Fristen, Leistungen oder Beiträgen.
4. Der Patient entscheidet selbst und nimmt außerhalb der Praxis freiwillig Kontakt auf.
5. Ausgelegtes Material wird nicht ungefragt ausgehändigt. Es liegt da, das Team spricht niemanden darauf an, und wer fragt, bekommt es.

Grenze fünf betrifft allein das ausgelegte Material. Dass es einen Weg gibt, dürfen Sie im Behandlungsgespräch weiterhin von sich aus aussprechen, davon bleibt sie unberührt.

Diese fünf Sätze sind kein Papiertiger. Sie sind ein Prüfraster, an dem Sie jeden Handzettel, jede Formulierung und jede Teambesprechung messen können. Wenn ein Punkt kippt, kippt die ganze Linie.

Was sie nicht sind: eine Ausrede. Die Linie regelt, wie weit Sie gehen, nicht ob Sie etwas sagen. Der Anker dafür passt in einen Satz. Es gibt einen Weg, prüfen Sie ihn. Sagen dürfen Sie ihn, prüfen und entscheiden muss der Patient.

Praktisch heißt das: Sie beschreiben die Landschaft, Sie gehen nicht mit hinein. Der Unterschied liegt in zwei Wörtern. „Es gibt“ ist Information. „Für Sie wäre“ ist Beratung. Wer sich im Zweifel an diesem Paar orientiert, liegt fast immer richtig.

Ein Nebeneffekt, den Praxen oft unterschätzen: Die Rollentrennung schützt auch das Vertrauensverhältnis. Ein Patient, der das Gefühl hat, ihm werde etwas verkauft, hört bei allem

anderen ebenfalls schlechter zu. Wer dagegen erlebt, dass jemand ihm eine Tür zeigt und ihn dann in Ruhe lässt, kommt wieder.

Kapitel 3. Der erste Schritt kostet nichts und verspricht nichts

Wenn ein Patient von sich aus die Kostenfrage stellt, ist die Antwort immer dieselbe: erst einmal bei der gesetzlichen Kasse nachsehen. Das heißt zweierlei. Nachsehen, was die eigene Kasse hergibt, und vergleichen, was andere Kassen für dieselbe Situation vorsehen.

Fast jeder Patient ist gesetzlich versichert, und fast niemand weiß, was die eigene Kasse hergibt. Zwei Dinge sind dort hinterlegt. Erstens das Bonusprogramm. Kassen zahlen Boni für Vorsorge, Bewegung und andere nachgewiesene Aktivitäten. Was genau anerkannt wird, steht in der Satzung der jeweiligen Kasse, und die Unterschiede sind beträchtlich. Zweitens die Satzungs- und Extraleistungen. Manche Kassen beteiligen sich an Bereichen, die viele Versicherte automatisch für Selbstzahlerleistungen halten.

Was das im Einzelfall bedeutet, hängt von der Kasse und vom Verhalten des Versicherten ab. Deshalb stehen in diesem Buch keine Beträge. Wer eine allgemeingültige Zahl nennt, redet an der Wirklichkeit vorbei.

Was hier ausdrücklich nicht gemeint ist: ein Aufruf, die Kasse zu wechseln. Keine Kasse ist pauschal die bessere, und dieses Buch stellt keine Rangfolge auf. Beide Schritte gehören zusammen, die eigene Kasse prüfen und den Vergleich daneben legen. Was daraus folgt, entscheidet der Patient selbst und nicht in Ihrer Praxis.

Ein Punkt, der im Alltag für Verwirrung sorgt und den Sie kennen sollten, ohne ihn zu erklären: Bonus ist nicht gleich Bonus. Manche Kassen zahlen einen Geldbetrag aus, andere bezuschussen nur nachgewiesene Kosten. Das sind zwei verschiedene Dinge, und wer sie verwechselt, rechnet mit Geld, das in dieser Form nie kommt. Sie müssen das nicht auseinandersortieren. Es reicht zu wissen, dass es diesen Unterschied gibt, damit Sie keine Erwartung wecken, die die Kasse Ihres Patienten gar nicht bedient.

Wir fangen bewusst bei der größeren Betrachtung an. Über kassenboost.de kann jeder Patient selbst nachsehen, welche gesetzliche Kasse für seine Situation am meisten hergibt. Ausgewertet wird anhand der Satzungen, und was am Ende daraus wird, entscheidet der Patient allein. Von uns kommt keine Rangliste und kein Aufruf, die Kasse zu wechseln. Erst wenn diese Seite geklärt ist, wird über einen Zusatzschutz überhaupt gesprochen.

Diese Seite können Sie nennen, ohne etwas zu versprechen. Sie wird von der Healio GmbH betrieben, ist kostenlos, verlangt keine Anmeldung und setzt keine Tracking-Cookies. Der Satz dazu im Gespräch ist kurz: „Schauen Sie erst einmal, was Ihre Kasse zurückzahlt.“ Das kostet Ihre Praxis nichts, verspricht nichts und lässt die Entscheidung dort, wo sie hingehört.

Kapitel 4. Auslegen ist nicht Aushändigen

Zwischen diesen beiden Wörtern liegt der Unterschied zwischen einer sauberen und einer unsauberen Praxis.

Auslegen heißt: Es liegt etwas da. Im Wartebereich, auf dem Tresen, im Regal neben den anderen Unterlagen. Wer es sieht und wissen will, was es ist, nimmt es in die Hand. Niemand wird angesprochen, niemand muss reagieren, niemand muss sich erklären.

Aushändigen heißt: Jemand aus dem Team geht auf einen Patienten zu und gibt ihm etwas. Damit wird aus einem Angebot eine Ansprache. Der Patient sitzt in einer Situation, in der er sich schlecht entziehen kann, und die Praxis wird zum Absender einer Empfehlung, die sie fachlich nicht verantworten kann.

Die Linie ist deshalb einfach: Material liegt aus, das Team spricht niemanden darauf an, wer fragt, bekommt es. Diese Regel gilt für alle im Haus, auch für die Person am Empfang, die es besonders gut meint.

Damit die Linie hält, braucht das Team eine einzige Ansage, und die dauert zwei Minuten in der Besprechung: Wir sprechen niemanden darauf an. Fragt jemand, geben wir es ihm, sagen ehrlich dazu, dass wir den Einzelfall nicht beurteilen können, und ermutigen ihn, selbst nachzusehen. Mehr muss niemand auswendig lernen.

Wenn es kein Wartezimmer gibt

Hebammen arbeiten anders. Statt Wartebereich und Auslageregal gibt es Hausbesuche, Kurse und Geburtsvorbereitung in fremden Räumen. Trotzdem lässt sich die Linie halten, nur mit anderem Träger.

In Kursen funktioniert der Ablagetisch, auf dem ohnehin Unterlagen liegen. Wer nach dem Kurs blättert, nimmt mit, was ihn interessiert. Im Hausbesuch trägt eine Mappe mit allgemeinen Unterlagen, aus der die Familie sich bedient, wenn sie will. Eine digitale Variante erfüllt denselben Zweck: eine Seite, auf der alles steht, und deren Adresse Sie nennen, wenn jemand fragt. Nichts davon wird in die Hand gedrückt, und niemand wird beim Hausbesuch auf Geld angesprochen.

Der Maßstab bleibt in jeder dieser Situationen derselbe: Der erste Schritt muss vom Patienten kommen.

Kapitel 5. Wie daraus ein Gesundheitsbudget werden kann

Jetzt zum Mechanismus, um den es eigentlich geht. Wer ihn verstanden hat, redet über die Kostenfrage souveräner, auch wenn er selbst nie in die Details geht.

Die meisten Menschen denken über Zusatzversicherung nach, indem sie Tarife vergleichen. Wir betrachten das Thema ganzheitlich und drehen die Reihenfolge um. Zuerst die gesetzliche Kasse, danach der private Zusatz.

Der Ablauf hat drei Stufen. Erstens die richtige Kasse: Was sieht sie über Satzung und Bonusprogramm überhaupt vor, und was ist dort ungenutzt. Zweitens den Bonus tatsächlich heben, also die Nachweise einreichen, die ohnehin anfallen. Drittens mit dem gehobenen Bonus einen Zusatzschutz finanzieren, statt das Geld im Alltag versickern zu lassen.

Zwei Dinge gehören dabei sauber auseinandergehalten. Eine Ersparnis beim Beitrag ist das eine, ein Bonus ist etwas anderes. Beides sind eigene Rechnungen, und sie werden nicht zu einer Summe addiert. Was an einer Stelle frei wird, kann an anderer Stelle eingesetzt werden, aber das ist eine Umschichtung und kein Zuwachs.

Warum diese Reihenfolge und nicht die übliche: Wer mit dem Tarifvergleich anfängt, sucht nach dem günstigsten Vertrag für ein Problem, das an anderer Stelle vielleicht schon teilweise gelöst ist. Wer mit der gesetzlichen Kasse anfängt, sieht zuerst, was ohnehin bereitliegt, und entscheidet danach, was noch fehlt. Das ist der Grund, warum wir die Versorgung als Ganzes betrachten und nicht anbieterweise.

Am Ende dieser Kette steht das, was wir Gesundheitsbudget nennen: bis zu 3.000 EUR in zwei Jahren, je nach Tarif und persönlichen Voraussetzungen. Diese Zahl ist keine Zusage, und man stellt sie einem Patienten nicht in Aussicht. Es ist die Obergrenze eines Rahmens, in dem ambulante Behandlungen, Vorsorge und weitere Bereiche zusammenkommen.

Was ein Zusatzschutz ist, nüchtern

Ein Zusatzschutz ist ein Vertrag mit monatlichem Beitrag. Er greift ab Vertragsbeginn. Was vorher angefangen hat, wird nicht nacherstattet. Gesundheitsfragen sind möglich. Erstattet wird nach den Bedingungen des jeweiligen Vertrags, und die geht der Patient mit dem Anbieter durch, nicht mit Ihnen am Tresen.

Der Punkt, den Sie als Behandler kennen sollten: der erste Tag. Eine Behandlung, die nach dem Versicherungsbeginn neu beginnt, ist vom ersten Tag an mitversichert. Der hier gemeinte ambulante Zusatzschutz kennt keine Wartezeit. Für Ihre Praxis heißt das: Ein Patient, der heute einen Vertrag schließt und in drei Wochen mit einer neuen Serie bei Ihnen anfängt, ist für diese Serie im Rahmen seines Tarifs abgesichert.

Anders liegt es bei einer Behandlung, die schon läuft. Für sie gilt der Stand vor dem Vertrag, sie wird nicht nachträglich hineingenommen. Ob eine später neu auftretende Beschwerde oder eine abgeschlossene und danach neu begonnene Behandlung als neuer Fall zählt, richtet sich

allein nach den Versicherungsbedingungen des gewählten Tarifs. Aussprechen dürfen Sie trotzdem, dass es diesen Weg gibt, und genau darauf kommt es an: „Es gibt eine Möglichkeit, schauen Sie sie sich an.“ Die Vertragsdetails klärt der Patient danach mit dem Anbieter, und das ist auch richtig so, denn dort sitzen die Leute, die dafür geradestehen. Ihr Teil ist der Hinweis, und der ist mehr wert, als er klingt.

Das ist der ganze Sachverhalt. Wer ihn so weitergibt, macht keinem Patienten Hoffnungen, die sich später nicht halten lassen, und muss hinterher nichts zurücknehmen.

Kapitel 6. Formulierungshilfen

Die folgenden Sätze sind zum Aussprechen gedacht. Sie sind kurz, sie überreden niemanden, und jeder von ihnen bleibt innerhalb der fünf Grenzen. Sie richten sich in der Sie-Form an den Patienten. Passen Sie den Wortlaut Ihrem Sprachgefühl an, aber verändern Sie nicht, was die Sätze offenlassen.

Am Empfang

„Melden Sie sich einfach, wenn Sie einen neuen Termin möchten. Der Platz ist da.“

Hält die Tür offen, ohne nach dem Grund der Absage zu fragen.

„Das hören wir öfter. Dazu liegt hier vorne eine allgemeine Information, nehmen Sie sie gern mit.“

Reagiert auf eine Äußerung des Patienten, statt ihn anzusprechen, und bewertet nichts.

„Was Ihre Krankenkasse bei Ihnen vorsieht, steht in deren Satzung. Da können nur Sie selbst nachfragen.“

Verweist auf die Quelle, statt eine Auskunft zu geben, die die Praxis nicht geben kann.

„Wenn Sie möchten, schreibe ich Ihnen auf, wo Sie nachsehen können. Anrufen müssten Sie selbst.“

Der Patient bleibt derjenige, der handelt.

Im Behandlungsraum

„Ich sage Ihnen, was fachlich sinnvoll wäre. Wie Sie das finanzieren, entscheiden Sie, und behandeln werde ich Sie so oder so.“

Trennt Behandlung und Geld und nimmt den Druck aus der Situation.

„Für den Teil, den die Kasse nicht übernimmt, gibt es Wege. Ich sage Ihnen das, weil mir lieber ist, Sie wissen davon. Ob einer davon zu Ihnen passt, müssen Sie selbst prüfen, das kann ich nicht beurteilen.“

Nennt die Möglichkeit aktiv und verweigert trotzdem die Bewertung des Einzelfalls.

„Schauen Sie zuerst, was Ihre eigene Kasse zurückzahlt. Das kostet Sie nichts und Sie wissen danach mehr.“

Der erste Schritt bleibt auf der Seite der gesetzlichen Kasse, ohne Empfehlung zu irgendeinem Produkt.

„Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie über die Termine reden wollen. Lieber weniger und regelmäßig als ein Abbruch.“

Macht die Kostenfrage besprechbar, ohne sie beim Namen zu nennen.

Was besser nicht gesagt wird

„Da kann ich Ihnen jemanden empfehlen.“ Damit stehen Sie als Absender einer Empfehlung da.

„Das wird bestimmt erstattet.“ Eine Zusage, die Sie nicht einhalten können.

„Wechseln Sie doch die Kasse.“ Eine Empfehlung ohne Grundlage und weit jenseits Ihrer Rolle.

„Sie sollten sich das wirklich ansehen.“ Ein Satz, der überredet.

Ehrlich dazugesagt

Drei Punkte, die zu diesem Buch dazugehören, auch wenn sie sich nicht gut verkaufen.

Dieses Buch macht Ihre Praxis nicht zur Beratungsstelle. Es zeigt, wie weit Sie gehen dürfen, und es ermutigt Sie, so weit auch zu gehen. Mehr soll es nicht leisten.

Ein Zusatzschutz ist ein Vertrag mit monatlichem Beitrag und greift ab Vertragsbeginn, ohne Wartezeit. Eine danach neu begonnene Behandlung ist vom ersten Tag an mitversichert. Was vorher angefangen hat, wird nicht nacherstattet.

Was am Ende bei einem Patienten ankommt, hängt von seiner Kasse, seinem Tarif und seinen persönlichen Voraussetzungen ab. Deshalb stehen hier keine Beträge, die für alle gelten sollen.

Wenn Sie darüber sprechen wollen

Zwanzig Minuten am Telefon oder im Videocall reichen, um zu klären, was das für Ihre Praxis bedeutet. Ohne dass daraus etwas folgen muss.

Termin: healio.de/partner

Und eine Bitte zum Schluss. Denken Sie noch einmal an den Termin, der verschoben und nie wieder vereinbart wurde. Der Mensch dahinter hat seine Rechnung am Ende still selbst bezahlt oder die Behandlung abgebrochen, während im selben Jahr Beträge bei seiner Kasse lagen, die niemand abgerufen hat. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil es ihm niemand gesagt hat.

Sie sind für viele Menschen die erste Stelle, an der überhaupt über Gesundheit gesprochen wird. Helfen Sie mit, die Leute zu informieren, dass es eine Lösung gibt. Ob ein Patient sie nutzt, ist seine Entscheidung, und prüfen muss er selbst. Aber sie zu verschweigen, wäre ein Versäumnis, für das wir gemeinsam geradestehen.

Rechtliche Hinweise

Das ist Werbung, keine Rechts- oder Versicherungsberatung für Ihre Praxis. Die Healio GmbH vermittelt Versicherungen. Erstinformation: healio.de/erstinformation.

Healio GmbH, Hamburg, healio.de. Direkt: Frank Steinfurt, 0176 241 531 88.

kassenboost.de wird von der Healio GmbH betrieben. Die Nutzung ist kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Tracking-Cookies.